JEDEN PRZYPADEK TYGODNIOWO™ · BONUS 3

Szablony Prezentacji Przypadków dla Kolegów

Gotowe struktury do opowiedzenia o przypadku w 60 sekund, 5 minut lub na plakacie, szablony z nawiasami kwadratowymi i lista kontrolna dokumentacji.

Kompendium Ortodonty

Spis treści

Przed prezentacją: cztery zasady

Prezentacja 60-sekundowa

Prezentacja 5-minutowa

Prezentacja plakatowa

Prośba o opinię pisemną od kolegi

Lista kontrolna dokumentacji: zdjęcia, modele, zdjęcia rentgenowskie

Porównanie przed / po

Częste błędy w prezentacji

Następny krok

NA POCZĄTEK

Przed prezentacją: cztery zasady

Ten sam kręgosłup bez względu na format.

1. **Określ jedno pytanie.** "Czego oczekuję w tym przypadku?" Opinii, decyzji, nauki? Pierwsze i ostatnie zdanie prezentacji muszą łączyć się z tym pytaniem.
2. **Używaj tej samej kolejności.** Dane i skarga → wyniki → lista problemów → plan → pytanie lub wynik.
3. **Anonimizować pacjenta.** Usunąć identyfikatory takie jak imię, numer dokumentacji i data. W przypadku zdjęć twarzy sprawdzić formularz zgody używany w danej klinice.
4. **Dokumentacja musi być standardowa.** Ten sam kąt, to samo światło, ta sama kolejność. Zaznaczyć listę kontrolną dokumentacji przed prezentacją.

FORMAT	KIEDY	GŁÓWNY CEL
60 sekund	Krótka konsultacja w klinice, rozmowa na korytarzu	Uzyskanie opinii w sprawie jednej decyzji
5 minut	Spotkanie przypadków, grupa robocza	Omówienie planu lub opowiedzenie o zakończonym przypadku
Plakat	Kongresy i wydarzenia naukowe	Uczynienie przypadku zrozumiałym na pierwszy rzut oka

FORMAT 1

Prezentacja 60-sekundowa

Cztery bloki, każdy po jedno-dwa zdania.

CZAS	BLOK	TREŚĆ
0–10 sek	Dane i skarga	Wiek, płeć, stan wzrostu, skarga pacjenta własnymi słowami.
10–30 sek	Główne wyniki	Relacja trzonowców/kłów, nagryz poziomy/pionowy, stłoczenie, dwie-trzy wartości cefalometryczne, ważna historia.
30–45 sek	Problem i opcje	Najważniejszy problem i dwie opcje, które rozważasz.
45–60 sek	Pytanie	Czego dokładnie oczekujesz od kolegi.

Szablon

[Wiek]-letni, **[stan wzrostu] [dziewczynka / chłopiec / kobieta / mężczyzna]**. Skarga: "**[skarga pacjenta]**".

Relacja trzonowców **[prawa / lewa]**, nagryz poziomy **[mm]**, nagryz pionowy **[mm]**. Stłoczenie w górze **[mm]**, w dole **[mm]**. ANB **[°]**, FMA **[°]**. Ważna historia: **[nawyk / uraz / zdrowie ogólne]**.

Moim zdaniem głównym problemem jest **[problem]**. Rozważam dwie opcje: **[opcja 1]** lub **[opcja 2]**.

Chciałbym zapytać: **[jedno, jasne pytanie]**?

Wypełniony przykład (fikcyjny)

13-letni chłopiec, blisko skoku wzrostowego. Skarga: "Moje zęby są wysunięte."

Relacja trzonowców obustronnie klasa II pełna, nagryz poziomy 8 mm, nagryz pionowy 5 mm. Stłoczenie w górze 4 mm, w dole 3 mm. ANB 6°, FMA 25°. Rok temu uraz z pęknięciem korony siekacza górnego.

Moim zdaniem głównym problemem jest klasa II związana z retruzją żuchwy i zwiększony nagryz poziomy. Rozważam dwie opcje: rozpoczęcie od aparatu czynnościowego lub kamuflaż z ekstrakcjami po zakończeniu wzrostu.

Chciałbym zapytać: Czy u tego pacjenta z historią urazu należałoby teraz rozpocząć leczenie aparatem czynnościowym?

FORMAT 2

Prezentacja 5-minutowa

10 slajdów, łącznie około 5 minut. Jeden pomysł na slajd.

SLAJD	CZAS	TYTUŁ	TREŚĆ
1	30 sek	Tytuł i pytanie	Tytuł przypadku i jedno pytanie lub główne przesłanie prezentacji.
2	30 sek	Dane i skarga	Wiek, stan wzrostu, skarga, istotna historia.
3	40 sek	Zdjęcia zewnątrzustne	Przód w spoczynku, przód w uśmiechu, profil. Interpretacja profilu w jednym zdaniu.
4	40 sek	Zdjęcia wewnątrzustne	Przód, prawy, lewy, górny i dolny okluzyjny. Wyniki zwarcia w kolejności.
5	30 sek	Zdjęcia rentgenowskie	Wyniki pantomogramu (w kolejności Narzędzia 1) i cefalometria boczna.
6	30 sek	Podsumowanie cefalometryczne	Osiem pomiarów i interpretacja w trzech zdaniach: strzałkowo, pionowo, zębowo.
7	30 sek	Lista problemów	Strzałkowo, pionowo, poprzecznie, miejsce i skarga pacjenta.
8	30 sek	Cele i plan	Cele, opcje i wybrany plan; uzasadnienie.
9	20 sek	Proces lub wynik	Obecny etap w trwającym przypadku; przed/po w zakończonym.
10	20 sek	Pytanie lub nauka	Pytanie do dyskusji lub lekcja płynąca z tego przypadku.

Slajd listy problemów · szablon

Strzałkowo: [relacja trzonowców/kłów, nagryz poziomy, źródło szkieletowe]

Pionowo: [nagryz pionowy, wzorzec pionowy]

Poprzecznie: [zgryz krzyżowy, linie środkowe]

Miejsce: [stłoczenie/luki w górze i dole, mm]

Skarga pacjenta: [skarga pacjenta]

Slajd planu · szablon

Cele: 1) [cel] 2) [cel] 3) [cel]

Opcje: A) [opcja] · B) [opcja]

Wybrany plan i uzasadnienie: [plan], ponieważ [uzasadnienie].

Zakotwienie i retencja: [plan zakotwienia] · [plan retencji]

FORMAT 3

Prezentacja plakatowa

Tekst na tyle krótki, by przeczytać go z metra, układ zrozumiały na pierwszy rzut oka.

Tytuł
[Tytuł opisujący przypadek w jednym zdaniu] · [Nazwa instytucji lub kliniki, zgodnie z wymogami wydarzenia]

Wstęp
[Dlaczego przypadek jest interesujący, 2–3 zdania]

Dane przypadku
[Wiek, skarga, historia; zdjęcia zewnątrzustne i wewnątrzustne]

Diagnoza
[Tabela podsumowania cefalometrycznego i lista problemów]

Plan
[Cele, opcje i wybrany plan]

Przebieg leczenia
[Etapy i czas; zdjęcia pośrednie]

Wynik
[Zdjęcia przed / po, porównanie końcowej cefalometrii]

Dyskusja i wnioski
[2–3 lekcje płynące z przypadku; krótko i konkretnie]

Lista kontrolna plakatu

- [ ] Przeczytałem zasady dotyczące wymiarów i formatu wydarzenia.
- [ ] Każda sekcja to maksymalnie kilka krótkich zdań.
- [ ] Zdjęcia w tym samym kącie i świetle, przed/po obok siebie.
- [ ] Wartości cefalometryczne w tabeli, niepowtarzane w tekście.
- [ ] Usunięto identyfikatory pacjenta; zgoda uzyskana zgodnie z formularzem używanym w danej klinice.
- [ ] Tytuł czytelny z daleka.

SZABLON

Prośba o opinię pisemną od kolegi

Krótka, uporządkowana wiadomość skupiona na jednym pytaniu otrzymuje szybszą i jaśniejszą odpowiedź.

Ortodonta do kolegi

Kolego **[Imię kolegi]**, cześć,

Proszę o krótką opinię w sprawie pewnego przypadku. **[Wiek]**-letni **[stan wzrostu]** pacjent. Główne wyniki: **[relacja trzonowców, nagryz poziomy, pionowy, stłoczenie]**; ANB **[°]**, FMA **[°]**.

Zastanawiam się nad dwiema opcjami: **[opcja 1]** i **[opcja 2]**. Moja skłonność to **[opcja]**, ponieważ **[uzasadnienie]**.

Moje pytanie: **[jedno pytanie]**? Dokumentacja w załączniku jest zanonimizowana.

Dzięki, **[Imię i nazwisko]** · **[Nazwa kliniki]**

Notatka konsultacyjna do chirurga, periodontologa lub protetyka

Pacjent: **[kod dokumentacji]**, **[wiek]** · **Powód konsultacji:** **[np. ocena opcji chirurgicznych / potwierdzenie stabilności periodontologicznej / plan miejsca pod implant]**

Wyniki ortodontyczne: **[krótkie podsumowanie]**

Plan ortodontyczny: **[planowane ruchy zębów i przewidywane etapy]**

Czego oczekuję: **[jasne pytanie lub potwierdzenie]**

Załączniki: **[zdjęcia, zdjęcia rentgenowskie, podsumowanie cefalometryczne]**

LISTA KONTROLNA

Lista kontrolna dokumentacji

Ta sama lista przy każdym początku, etapie pośrednim i końcu. Uzupełnić braki przed prezentacją.

Zdjęcia zewnątrzustne

- [ ] Przód, w spoczynku
- [ ] Przód, w uśmiechu
- [ ] Profil, w spoczynku
- [ ] Uśmiech pod kątem trzech czwartych
- [ ] W razie potrzeby od dołu (dla asymetrii)

Zdjęcia wewnątrzustne

- [ ] Przód, w zwarciu
- [ ] Prawy policzkowy
- [ ] Lewy policzkowy
- [ ] Górny okluzyjny
- [ ] Dolny okluzyjny
- [ ] Widok nagryzu poziomego (z boku)

Modele

- [ ] Pełny zapis łuku górnego i dolnego (cyfrowy lub gipsowy)
- [ ] Zapis zwarcia
- [ ] W razie potrzeby zapis relacji centralnej
- [ ] Analiza miejsca i wyniki Boltona

Zdjęcia rentgenowskie

- [ ] Pantomogram (odczytany w kolejności Narzędzia 1)
- [ ] Cefalometria boczna i trasowanie
- [ ] Dodatkowa diagnostyka obrazowa zgodnie ze wskazaniami
- [ ] Zdjęcia rentgenowskie pośrednie i końcowe

Standard zdjęć

- [ ] To samo tło i światło; brak odblasków.
- [ ] Głowa w naturalnej pozycji, na zdjęciu profilowym płaszczyzna Frankfurta w przybliżeniu równoległa do podłoża.
- [ ] Użycie retraktora i lusterka na zdjęciach wewnątrzustnych takie samo przy każdym zapisie.
- [ ] Brak imienia pacjenta w nazwach plików; kod dokumentacji kliniki i etap zapisu (początek / pośredni / koniec).

PREZENTACJA WYNIKU

Porównanie przed / po

Te same warunki, aby uczciwie pokazać zmianę.

ZASADA	DLACZEGO
Ten sam kąt i to samo powiększenie	Różny kąt może wyolbrzymić lub ukryć zmianę.
To samo światło i tło	Różnica w kolorze i kontraście jest postrzegana jako zmiana.
Obok siebie lub jeden nad drugim	Widz musi być w stanie sam dokonać porównania.
Podać wartości cefalometryczne w tabeli	Początek, koniec i różnica w trzech kolumnach.
Powiedz o ograniczeniach	Zapisanie celów, których nie udało się osiągnąć, czyni prezentację wiarygodną.

Tabela porównania cefalometrycznego · szablon

POMIAR	POCZĄTEK	KONIEC	RÓŻNICA
SNA			
SNB			
ANB			
Wits			
FMA			
SN-GoMe			
IMPA			
U1-SN			

UNIKAĆ

Częste błędy w prezentacji

Jedno zdanie poprawki dla każdego z nich.

BŁĄD	KOREKTA
Zostawianie pytania na sam koniec	Zadać pytanie w pierwszym zdaniu, powtórzyć w ostatnim.
Odczytywanie wszystkich wartości cefalometrycznych	Osiem pomiarów w tabeli, ustnie tylko interpretacja w trzech zdaniach.
Pomijanie listy problemów i zaczynanie od aparatu	Najpierw lista problemów i cele, potem mechanika.
Zdjęcia przed/po w różnym kącie i świetle	Stosować listę kontrolną dokumentacji na początku.
Zostawianie identyfikatorów pacjenta na slajdzie	Sprawdzić wszystko przed prezentacją, w tym nazwy plików.
Prezentowanie tylko udanych przypadków	Prezentowanie przypadku, w którym utknęło się w martwym punkcie, jest często bardziej pouczające.
Przekraczanie czasu	Przećwiczyć raz na głos ze stoperem.

Materiał ma charakter edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Wybrać przypadek w tym tygodniu i wypełnić 60-sekundowy szablon. Przypadki z **Tygodni 49–52** w 52-Tygodniowym Programie Ćwiczeń na Przypadkach są idealne do ćwiczeń prezentacji.

Do slajdu podsumowania cefalometrycznego użyć metody trzech zdań z **Zeszytu Ćwiczeń z Pomiarów Cefalometrycznych**. Do listy problemów i planu otworzyć **Narzędzie 4 · 4-Etapowy Planer Kliniczny** z Kompendium.